

Un enfant d'âge scolaire dans votre cabinet

Pour les médecins de famille, les infirmiers et les professionnels de santé — soigner un enfant d'âge primaire autiste (environ 6 à 11 ans).

L'idée centrale

L'autisme, vu sous l'angle du **monotropisme**, signifie que l'attention d'un enfant se verrouille dans quelques « tunnels » profonds et intenses — vifs à l'intérieur, faibles à l'extérieur, et coûteux à changer. L'école est souvent le premier véritable test de stress : bruyante, visuellement chargée et imprévisible, elle draine l'attention qui devrait être allouée au reste. Beaucoup d'enfants **tiennent le coup à l'école et s'effondrent après** — y compris dans votre salle d'attente. La clé est de travailler avec le tunnel, et non contre lui.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous observez...	Ce qui se passe souvent
« Tout va bien à l'école », meltdowns ou shutdowns à la maison ou en clinique	L'enfant a camouflé toute la journée ; la maison — et votre cabinet — est l'endroit où le masque tombe enfin
Maux d'estomac, maux de tête, « refuse de manger » ; pas de cause organique claire	Une charge sensorielle et sociale élevée s'exprime par le corps ; courants également : comorbidités GI et du sommeil
Difficulté à démarrer, basculer ou s'arrêter ; semble « paresseux » ou provocateur	Inertie autistique — changer de voie mentale coûte une énergie réelle, pas de la volonté
Perte soudaine de compétences acquises l'année dernière	Souvent un burnout / un déplacement des ressources attentionnelles sous l'effet de la surcharge, et non une régression réelle
Prend les choses littéralement ; a besoin de temps pour répondre	Communication littérale sur un canal unique + temps de traitement

Essayez ceci

- **Envoyez un formulaire de pré-visite** (l'outil *AHAT* d'AASPIRE, autismandhealth.org) et demandez au parent ce qui aide ; accueillez le port d'un casque, de lunettes de soleil et d'un objet de confort.
- **Réservez le créneau le plus calme**, tamisez les lumières, coupez les bips ; permettez la présence d'un adulte de confiance.
- **Expliquez chaque étape avant de la réaliser**, avec des phrases courtes et littérales ; laissez l'enfant stimmer ou tenir un objet d'intérêt.
- **Interrogez sur la charge scolaire et la récupération**, et pas seulement sur les symptômes — « Combien de temps faut-il pour récupérer après une journée d'école ? » signale la surcharge.
- **Co-créez une routine de santé simple** (même pièce, même séquence) pour les visites répétées.

Évitez ceci

- Traiter la composure masquée comme un signe que « tout va bien », ou un shutdown comme un refus de s'engager.

- Longues instructions verbales, procédures surprises, ou phrases comme « sois courageux ! ».
- Pousser davantage lorsque les compétences ont chuté — la réponse fondée sur les preuves au burnout est de **réduire les exigences et de restaurer le repos et les intérêts**.

Quand demander plus de soutien

Soyez attentif au **burnout autistique** (épuisement chronique, perte de compétences, tolérance réduite aux stimuli) — il est *distinct de la dépression* et du stress ordinaire, et est aggravé par le camouflaging. Dépistez les comorbidités courantes : **anxiété, TDAH (AuDHD), troubles du sommeil et problèmes GI**. Interrogez directement sur l'assiduité scolaire et le harcèlement. Orientez vers le soutien scolaire (SESSAD/AESH) et les groupes de parents dirigé par des autistes.

Si l'enfant est une fille

Les filles de cet âge **camouflent énormément** et sont fréquemment oubliées ou mal diagnostiquées (anxiété, « timidité »). Prenez les préoccupations parentales au sérieux même quand les enseignants voient un enfant calme et docile — le coût est payé hors vue.

À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — le brief **Monotropisme** et le **Guide pour les praticiens et professionnels de santé** (Parties 3.2 & 4). Utilisez le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un avis médical ni un outil de diagnostic**. Adaptez-le à l'enfant individuellement.

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2019, *Monotropism at School*; 2023); Dwyer (2025); Edgar (2024, régression/burnout); Raymaker et al. (2020); AASPIRE AHAT; Kelly Mahler (2024). Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.